



Guia Completo de Estudos

Introdução à Enfermagem

🎓 Curso: Enfermagem

📋 EN_430 • CH: 120h

🌐 EAD / Subsequente

⚡ Método 80/20

🗺️ Como usar este guia

- 1 Comece pela **Teoria das Necessidades Básicas** (fundação)
- 2 Avance para **SAE e Anotação** (processo de trabalho)
- 3 Estude **Medicação e Assepsia** (procedimentos base)
- 4 Complete com os **demais módulos** na ordem sugerida
- 5 Finalize com os **Exercícios de Fixação e Flashcards**



Como Estudar com Este Material

Este Guia Completo reúne **todo o conteúdo essencial** da disciplina de Introdução à Enfermagem (EN_430) em **10 módulos** organizados do fundamento à prática. Cada módulo contém:

-  **Conteúdo teórico** — conceitos fundamentais explicados de forma clara
-  **Tabelas e quadros** — informações organizadas para consulta rápida
-  **Mnemônicos** — técnicas de memorização para fixar o conteúdo
-  **Pontos de atenção** — destaques para o que mais cai em provas
-  **Exercícios** — questões ao final de cada bloco principal

 **Dica:** Estude um módulo por dia. Ao final de cada módulo, revise os flashcards correspondentes e consulte o resumo de 5 minutos para fixar.

1 Teoria das Necessidades Básicas

Fundamento

Conceito Fundamental

Desenvolvida por **Wanda de Aguiar Horta** (1979), a Teoria das Necessidades Humanas Básicas é o **alicerce da enfermagem moderna brasileira**. Ela se baseia na hierarquia de **Maslow**, adaptando-a para a realidade do cuidado de enfermagem.

Os 3 Níveis de Necessidades

Psicobiológicas

- Oxigenação / Circulação
- Hidratação / Nutrição
- Eliminação (urinária, intestinal)
- Sono e Repouso
- Locomoção / Atividade física
- Cuidado corporal / Integridade cutânea
- Regulação térmica / Neurológica

Psicossociais

- Comunicação / Interação social
- Lazer / Recreação
- Segurança emocional
- Autoestima / Autoconfiança
- Amor / Aceitação / Pertencimento

Psicoespirituais

- Crenças religiosas / Espiritualidade
- Valores éticos e morais
- Esperança / Sentido da vida
- Gratidão / Perdão / Transcendência

 **Aplicação prática:** Ao avaliar um paciente, identifique **primeiro** as necessidades psicobiológicas (urgência vital), depois as psicossociais, e por fim as psicoespirituais. Ex: um paciente com dor (psicobiológica) precisa ser medicado antes de receber apoio emocional.

Relação com Maslow

Hierarquia de Maslow	Necessidades de Horta	Exemplo em Enfermagem
Fisiológicas	Psicobiológicas	Oxigenação, alimentação
Segurança	Psicobiológicas	Conforto, proteção de quedas
Social (Pertencimento)	Psicossociais	Apoio familiar, visitas
Estima	Psicossociais	Autocuidado, privacidade

Autorrealização

Psicoespirituais

Assistência religiosa

2

SAE — Sistematização da Assistência de Enfermagem



Processo

O que é a SAE?

A **SAE** é uma metodologia científica que organiza o trabalho do enfermeiro, garantindo cuidado individualizado, seguro e de qualidade. É **privativa do enfermeiro** e regulamentada pela **Resolução COFEN 358/2009**.

As 5 Etapas da SAE

#	Etapas	Descrição	Ferramenta
1	Histórico	Coleta de dados: entrevista + exame físico + prontuário	Roteiro de anamnese
2	Diagnóstico	Julgamento clínico sobre as respostas do paciente	Taxonomia NANDA-I
3	Planejamento	Definição de resultados esperados e intervenções	NOC e NIC
4	Implementação	Execução das intervenções prescritas	Prescrição de enfermagem
5	Avaliação	Verificação se os resultados foram alcançados	Evolução de enfermagem

 **Mnemônico: HDPIA** — "Hoje, Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Avaliação"

 **Ponto de prova:** A SAE é **privativa do enfermeiro** (não pode ser delegada a técnicos ou auxiliares). As etapas de **Histórico, Diagnóstico e Planejamento** são exclusivas do enfermeiro. A **Implementação** pode ser compartilhada com a equipe.

Taxonomias Utilizadas

- **NANDA-I** — Diagnósticos de Enfermagem (ex: "Integridade da pele prejudicada")
- **NIC** — Classificação das Intervenções (ex: "Cuidados com lesão por pressão")
- **NOC** — Classificação dos Resultados (ex: "Cicatrização de feridas")

3

Anotação de Enfermagem e Terminologias Técnicas



Registro

Princípios da Anotação de Enfermagem

A anotação de enfermagem é o **registro escrito** de todas as observações, cuidados e ocorrências relacionados ao paciente. Tem valor legal, ético e clínico.

Princípios

- **Objetividade** — direto ao ponto
- **Cronologia** — ordem dos fatos
- **Clareza** — sem rasuras, letra legível
- **Compleitude** — data, hora, assinatura + COREN
- **Sigilo** — informações confidenciais

Erros Comuns

- Usar siglas não padronizadas
- Anotações subjetivas ("paciente parece triste")
- Deixar espaços em branco
- Rasuras ou corretivo
- Anotar antes de realizar o procedimento

Estrutura SOAP

Letra	Significado	Exemplo
S	Subjetivo — queixas do paciente	"Refere dor abdominal 7/10"
O	Objetivo — dados observados/mensurados	"PA 140x90, FC 98 bpm, abdômen distendido"
A	Avaliação — análise clínica	"Possível retenção urinária"
P	Plano — intervenções realizadas/previstas	"Instalado SVD, mantido em observação"

Principais Terminologias Técnicas

Afebril	Sem febre (36-37°C)	Normocárdico	FC normal (60-100 bpm)
Eupnéico	FR normal (16-20 irpm)	Normotenso	PA normal (~120x80 mmHg)
Anictérico	Sem icterícia	Normocorado	Pele/mucosas coradas
Hidratado	Turgor preservado	Lúcido e Orientado	Consciente (L+O)
Diurese presente	Urina normal	Bradicárdico	FC < 60 bpm
Taquicárdico	FC > 100 bpm	Taquipneico	FR > 20 irpm
Deambulando	Paciente andando	Eliminações fisiológicas	Urina e fezes normais

4 Administração de Medicamentos

 Essencial

Os 7 Certos da Medicação

#	Certo	O que significa	Cuidado prático
1	Paciente	Conferir nome + leito + pulseira	Perguntar nome ao paciente
2	Medicamento	Conferir com a prescrição	Ler rótulo 3 vezes
3	Dose	Calcular e confirmar	Usar regra de 3
4	Via	Via correta (enteral/parenteral)	Verificar compatibilidade
5	Horário	Horário e intervalo corretos	Não atrasar nem adiantar
6	Registro	Anotar após administrar	Nunca anotar antes
7	Orientação	Informar o paciente	Explicar medicação e efeitos

 **Mnemônico: PMDVHRO** — Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Orientação

Vias Enterais × Parenterais

Enterais (via TGI)

- **Oral (VO)** — comprimidos, xaropes
- **Sublingual (SL)** — absorção rápida
- **Sonda NG/NE** — pacientes sem deglutição

Parenterais (fora do TGI)

- **ID** — 10-15°, 0,5 mL (PPD, BCG)
- **SC** — 45-90°, 1-2 mL (insulina)
- **IM** — 90°, 3-5 mL (Benzetacil)
- **EV** — 25-45°, volume variável (soros)

Cálculo de Medicamentos

Fórmulas essenciais:

- **Regra de 3:** Dose prescrita × Volume total ÷ Dose disponível
- **Macrogotas/min:** Volume (mL) ÷ (Tempo (h) × 3)
- **Microgotas/min:** Volume (mL) ÷ Tempo (h)
- **Microgotas = Macrogotas × 3**

 **Exemplo:** Prescrição: SF 0,9% 500 mL em 6h. Quantas macrogotas/min?

Cálculo: $500 \div (6 \times 3) = 500 \div 18 = \sim 28 \text{ gotas/min}$

Locais da Via IM

Músculo	Local	Vol. Máx.
---------	-------	-----------

Deltoide	Face externa do braço	2 mL
Vasto Lateral da Coxa	Antero-lateral da coxa	5 mL
Glúteo Máximo	Quadrante superior externo	4 mL

5

Assepsia, Antissepsia e Higiene do Paciente

Base

 Conceitos Fundamentais Assepsia

- Ausência total de microrganismos
- Campo estéril, material esterilizado
- Centro cirúrgico, procedimentos invasivos

 Antissepsia

- Redução de microrganismos na pele
- Álcool 70%, PVPI, Clorexidina
- Antes de procedimentos, curativos

 5 Momentos da Higienização das Mãos (OMS)

1. **Antes** de tocar o paciente
2. **Antes** de procedimento limpo/asséptico
3. **Após** risco de exposição a fluidos corporais
4. **Após** tocar o paciente
5. **Após** tocar superfícies próximas ao paciente

 Técnica para Calçar Luvas Estéreis

1. Higienizar as mãos (degermação)
2. Abrir o envelope estéril pela parte externa
3. Calçar 1ª luva com mão dominante (pegar pelo avesso do punho)
4. Calçar 2ª luva (dedos enluvados sob o punho dobrado da 2ª luva)
5. Mãos postas à frente, acima da cintura — não tocar em nada não estéril!

 Banho no Leito — Sequência Correta

Sequência: Olhos → Face → Braços → Tórax → Abdômen → Membros Inferiores → Períneo → Dorso

Materiais: Bacia com água morna, sabonete neutro, toalhas, luvas, roupa de cama limpa

6 Curativos e Feridas

 Procedimento Classificação de Feridas

Critério	Classificação	Exemplo
Causa	Cirúrgica	Incisão cirúrgica (limpa)
	Traumática / Ulcerativa	Escoriação / Lesão por pressão
Contaminação	Limpa	Cirurgia eletiva, sem infecção
	Limpa-contaminada	Cirurgia com abertura de víscera
	Contaminada	Trauma com sujidade visível
	Infectada	Pus, secreção purulenta
Tempo	Aguda / Crônica	< 6 semanas / > 6 semanas

 Principais Coberturas

Cobertura	Indicação	Troca
Hidrocoloide	Feridas secas a pouco exsudativas	A cada 3-5 dias
Alginato de Cálcio	Feridas muito exsudativas	1-2x ao dia
Carvão Ativado + Prata	Feridas infectadas com odor	A cada 2-3 dias
Espuma (poliuretano)	Feridas moderadamente exsudativas	A cada 3-5 dias
Filme Transparente	Proteção de pele íntegra, cateteres	A cada 7 dias

 Lesão por Pressão (LPP) — Estágios NPUAP

Estágio	Descrição
1	Pele íntegra com eritema não branqueável
2	Perda parcial da pele (bolha, abrasão)
3	Perda total — gordura subcutânea visível
4	Perda total — osso/músculo expostos

 **Prevenção:** Mudança de decúbito a cada 2h, manter pele limpa e seca, usar colchão adequado.

 Passo a Passo do Curativo Simples

1. Higienizar as mãos + calçar luvas de procedimento
2. Remover curativo anterior
3. Avaliar ferida (tamanho, aspecto, odor, exsudato, bordas)
4. Limpar com SF 0,9% (movimento centro → periferia)
5. Secar bordas com gaze estéril
6. Aplicar cobertura indicada
7. Cobrir com gaze e fixar
8. Desprezar resíduos + higienizar mãos
9. Registrar: aspecto, cobertura, data e hora + COREN

7 Oxigenoterapia e Cateterismos

 Procedimentos

Oxigenoterapia — Dispositivos

Dispositivo	Fluxo (L/min)	FiO ₂	Indicação
Cateter Nasal	1 - 5	24 - 40%	Baixa demanda, confortável
Máscara Simples	5 - 10	35 - 50%	Oxigenação moderada
Máscara Venturi	Variável	24 - 50% (exata)	DPOC, FiO ₂ controlada
Máscara c/ Reservatório	10 - 15	60 - 95%	Alta demanda, emergência

 **Cuidados:** Umidificar O₂, monitorar SatO₂ (≥95%), trocar dispositivo a cada 24h, manter cabeceira elevada.

Cateterismos — Tipos e Indicações

Sonda Nasogástrica (SNG)

- Descompressão gástrica
- Lavagem gástrica
- Coleta de conteúdo gástrico

Sonda Nasoenteral (SNE)

- Administração de dieta
- Administração de medicações
- Posição: intestino (pós-pilórica)

Sonda Vesical

- Esvaziamento vesical
- Controle de diurese
- Coleta de urina estéril

Sonda Retal

- Eliminação de gases
- Fecaloma

 **Verificação da SNG:** Raio-X (padrão ouro) ou aspirar conteúdo + verificar pH < 5,5. **Não usar** teste de borbulhamento em copo d'água!

8

Exames, Coletas e Medidas Antropométricas



Diagnóstico



Coleta de Exames

Exame	Técnica	Cuidados
Hemograma	Punção venosa (jejum 8-12h)	Torniquete, assepsia, frasco roxo
Urina (EAS)	Jato médio, 1ª urina da manhã	Higiene íntima, frasco estéril
Urocultura	Jato médio em frasco estéril	Desprezar 1º jato, coletar o médio
Parasitológico de fezes	Coleta de 3 amostras (dias alternados)	Frasco específico, conservar sob refrigeração
Escarro	Matinal, jejum, lavagem brônquica	Recipiente estéril, bochechar água antes
Urina 24h	Toda urina de 24h em frasco único	Desprezar 1ª urina, refrigerar



Medidas Antropométricas

Medida	Equipamento	Procedimento
Peso	Balança calibrada	Descalço, roupas leves
Altura	Estadiômetro	Posição ereta, descalço
IMC	Fórmula (peso/altura ²)	Classificar resultado
Circunferência abdominal	Fita métrica	Entre costela e crista ilíaca



Classificação do IMC (OMS)

< 18,5

- Magreza (abaixo do peso)

18,5 - 24,9

- Peso normal (eutrófico)

25,0 - 29,9

- Sobrepeso

≥ 30,0

- Obesidade (I, II, III)

9

Posições Hospitalares, Crioterapia, Termoterapia e Contenção



Posições da Cama Hospitalar

Posição	Descrição	Indicação
Fowler	45° (sentado)	Dispneia, alimentação, SNG/SNE
Semi-Fowler	30°	Conforto, repouso, prevenção broncoaspiração
Sims	Decúbito lateral	SNE, clister, exames retais
Trendelenburg	Inclinada (cabeça baixa)	Choque, hipotensão
Decúbito Dorsal	Barriga para cima	Exame físico, repouso

 **Mudança de decúbito:** reposicionar o paciente a cada **2h** para prevenir LPP.

Crioterapia × Termoterapia

Crioterapia (Frio — 20min)

- Edema agudo / Trauma
- Processo inflamatório inicial
- Dor aguda / Pós-operatório
- Hemorragia
- **Contraindicação:** hipersensibilidade ao frio, doença vascular periférica

Termoterapia (Calor — 20min)

- Contraturas musculares
- Abscesso / Dor crônica
- Processo inflamatório crônico
- Hematomas
- **Contraindicação:** sangramento ativo, tumor, edema agudo

Tipos de Contenção

Tipo	Descrição	Cuidados
Mecânica	Faixas (punho, tórax, joelhos)	Avaliar q 1h, liberar q 2h
Química	Sedativos / Neurolépticos	Prescrição médica obrigatória
Ambiental	Grades, cama baixa	Supervisão constante

 Contenção é **último recurso** — nunca usar como punição ou por conveniência!

10 Admissão, Transferência, Alta e Processo Pós-Morte



Admissão do Paciente

- **Identificação** — pulseira, nome, leito, prontuário
- **Sinais Vitais** — PA, FC, FR, Tax, SatO₂
- **Histórico de Enfermagem** — QP, HDA, HPP, alergias, medicações
- **Exame Físico** — cefalocaudal, sistemas
- **Orientações** — rotinas, horários, visitas
- **Pertences** — guardar e documentar objetos de valor



Transferência e Alta

Transferência

- Resumo de evolução
- Passagem de plantão completa
- Documentos e exames
- Comunicação entre unidades

Alta Hospitalar

- Resumo de alta
- Orientações ao paciente/cuidador
- Receitas e atestados
- Agendamento de retorno
- Desocupação do leito



Processo Pós-Morte

1. Confirmar óbito + registrar no prontuário
2. Aguardar declaração de óbito (médico)
3. Posicionar corpo em decúbito dorsal
4. Realizar higiene corporal
5. Retirar dispositivos (sondas, drenos, cateteres)
6. Identificar corpo (pulseira, etiqueta)
7. Respeitar crenças religiosas
8. Comunicar e apoiar a família

 **Aspectos legais:** O enfermeiro não pode declarar óbito (atribuição médica). O preparo do corpo é responsabilidade da equipe de enfermagem.



Glossário de Terminologias Técnicas

Consulta

Afebril	Sem febre (36-37°C)	Anictérico	Sem icterícia (pele sem coloração amarelada)
Anúria	Ausência de diurese (< 50 mL/dia)	Balanço Hídrico	Diferença entre ingesta e perda de líquidos em 24h
Bradicárdico	FC < 60 bpm	Bradipneico	FR < 16 irpm
Cianose	Coloração azulada por má oxigenação	Deambulando	Paciente andando sem restrições
Disúria	Dificuldade/dor ao urinar	Diurese presente	Eliminação urinária normal
Edema	Inchaço por acúmulo de líquido intersticial	Eliminações fisiológicas	Urina e fezes dentro da normalidade
Epistaxe	Sangramento nasal	Eupnéico	FR normal (16-20 irpm)
Exantema	Erupção cutânea (manchas vermelhas)	Hematêmese	Vômito com sangue
Hemiparesia	Paralisia parcial de um lado do corpo	Hemiplegia	Paralisia total de um lado do corpo
Hidratado	Turgor e elasticidade da pele preservados	Hipertenso	PA > 140x90 mmHg
Hipotenso	PA < 90x60 mmHg	Inconsciente	Sem resposta a estímulos verbais
Intercorrência	Evento inesperado durante a assistência	Lúcido e Orientado (L+O)	Consciente, orientado no tempo e espaço
Melena	Fezes escuras com sangue digerido	Normocárdico	FC normal (60-100 bpm)
Normocorado	Coloração normal da pele/mucosas	Normotenso	PA normal (~120x80 mmHg)
Oligúria	Diurese diminuída (< 400 mL/dia)	Paresia	Fraqueza muscular parcial
Plegia	Paralisia total	Poliúria	Diurese aumentada (> 2500 mL/dia)
Prognóstico	Previsão da evolução do quadro clínico	Punção	Perfuração/introdução de agulha ou cateter

Sialorreia

Salivação excessiva

Taquicárdico

FC > 100 bpm

Taquipneico

FR > 20 irpm



Exercícios de Fixação — 20 Questões



Teste seu conhecimento

1. Quais são os 3 níveis da Teoria das Necessidades Básicas de Wanda Horta?

- a) Físicas, Mentais e Espirituais
- b) Psicobiológicas, Psicossociais e Psicoespirituais
- c) Orgânicas, Sociais e Religiosas
- d) Primárias, Secundárias e Terciárias

2. Qual a Resolução do COFEN que regulamenta a SAE?

- a) 272/2002
- b) 358/2009
- c) 429/2012
- d) 564/2017

3. Qual a sequência correta das 5 etapas da SAE?

- a) Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação → Histórico
- b) Histórico → Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação
- c) Planejamento → Histórico → Diagnóstico → Implementação → Avaliação
- d) Histórico → Planejamento → Diagnóstico → Avaliação → Implementação

4. Qual o ângulo de aplicação da via intramuscular (IM)?

- a) 10-15°
- b) 45°
- c) 90°
- d) 25-45°

5. Quantos e quais são os 7 Certos da Administração de Medicamentos?

- a) Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Orientação
- b) Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Ambiente

- c) Paciente, Medicamento, Dose, Tempo, Via, Registro, Orientação
- d) Paciente, Medicação, Dose, Hora, Registro, Orientações, Ambiente

6. Qual a diferença entre ASSEPSIA e ANTI-SEPSIA?

- a) Assepsia reduz microrganismos; antissepsia elimina totalmente
- b) Assepsia impede a entrada de microrganismos; antissepsia reduz na pele
- c) São sinônimos
- d) Assepsia é para objetos; antissepsia é para pessoas

7. Quais são os 5 Momentos da Higienização das Mãos (OMS)?

- a) Antes e após contato com paciente, antes de procedimento, após fluidos, após superfícies
- b) Ao chegar, ao sair, antes do almoço, após banheiro, ao final do plantão
- c) Antes e após cada medicação, ao acordar, antes de dormir
- d) Ao entrar no quarto, antes de tocar, após tocar, após luvas, após alimentos

8. Qual o volume máximo para aplicação no músculo deltoide?

- a) 1 mL
- b) 2 mL
- c) 3 mL
- d) 5 mL

9. O que significa "normocárdico" na terminologia técnica?

- a) Pressão arterial normal
- b) Frequência cardíaca normal (60-100 bpm)
- c) Temperatura normal
- d) Respiração normal

10. Para qual tipo de ferida o Alginato de Cálcio é mais indicado?

- a) Feridas secas
- b) Feridas muito exsudativas
- c) Pele íntegra
- d) Feridas fechadas

11. Qual o fluxo de oxigênio do Cateter Nasal?

- a) 1-5 L/min
- b) 5-10 L/min
- c) 10-15 L/min

d) 15-20 L/min

12. Qual a diferença entre SNG e SNE?

- a) SNG vai até o estômago; SNE vai até o intestino
- b) SNG vai pela boca; SNE vai pelo nariz
- c) SNG é para medicação; SNE é para coleta
- d) Não há diferença

13. Qual a posição indicada para paciente com dispneia?

- a) Decúbito dorsal
- b) Trendelenburg
- c) Fowler (45°)
- d) Sims

14. De quanto em quanto tempo deve-se realizar a mudança de decúbito?

- a) 30 min
- b) 1 hora
- c) 2 horas
- d) 4 horas

15. Qual IMC classifica o paciente com obesidade grau I?

- a) 25,0 - 29,9
- b) 30,0 - 34,9
- c) 35,0 - 39,9
- d) ≥ 40

16. Quando usar CRIOTERAPIA?

- a) Contraturas musculares crônicas
- b) Edema agudo, trauma recente
- c) Abscesso
- d) Dor crônica

17. Qual o método PADRÃO OURO para verificar posicionamento da SNG?

- a) Ausculta epigástrica
- b) Teste de borbulhamento
- c) Raio-X
- d) pH do aspirado

18. O que significa a sigla L+O na anotação de enfermagem?

- a) Leito + Observação
- b) Lúcido e Orientado
- c) Limpo e Organizado
- d) Local + Origem

19. Qual destes NÃO é um tipo de contenção?

- a) Mecânica
- b) Química
- c) Física (exercícios)
- d) Ambiental

20. Qual o primeiro passo no processo pós-morte?

- a) Retirar dispositivos invasivos
- b) Realizar higiene corporal
- c) Confirmar e registrar o óbito
- d) Identificar o corpo



Gabarito dos Exercícios

✓ Correção

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. B 9. B 10. B 11. A

12. A 13. C 14. C 15. B 16. B 17. C 18. B 19. C 20. C



Resultado: Acertou < 10 = precisa revisar os módulos 1-5 • 10-15 = bom, revise os pontos fracos • 16-20 = excelente, siga para os flashcards e pratique!